

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 129.13/I-KEP/DIR/II/2026

TENTANG
PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan medis yang baik, efektif, efisien dan berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia, fasilitas, prafasilitas, peralatan serta dana sesuai dengan prosedur yang memadai;
- b. bahwa agar pelayanan di RS Prima Husada Malang dapat terlaksana dengan baik perlu adanya panduan praktik klinis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RS Prima Husada Malang.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
2. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Organisasi Rumah sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/kemenkes/Per/XI/2006 tentang pedoman organisasi rumah sakit di lingkungan departemen kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Komite Mutu Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban RS dan Kewajiban Pasien;
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1087/MENKES/SK/VIII/2010 Tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit.
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
12. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;
13. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor: 1042.92/DPM/I-KEP/DIR/IX/2025 tentang Pengangkatan PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TENTANG PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)
- Kesatu : Memberlakukan Panduan Praktik Klinis (PPK) RS Prima Husada Malang sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;



Kedua : Keputusan Direktur ini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan disesuaikan kembali jika ada perubahan atau ada kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 13 Februari 2026



dr. Resti Lestantini, M.Kes

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
NOMOR 129.13/I-KEP/DIR/II/2026
TENTANG
CLINICAL PATHWAY

Daftar Isi

1. CVA.....	4
2. Dengue Fever	10
3. DM Ulkus dengan Tindakan Debridement	11
4. Kejang Demam.....	15
5. Pneumonia.....	18

1. CVA

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TAHUN 2026
CVA INFARK	
1. Pengertian (Definisi)	Defisit neurologik focal yang timbul mendadak, berlangsung lebih dari 24 jam, dan disebabkan oleh gangguan primer peredaran darah otak berupa thrombosis, embolisme, atau kelainan non-oklusif
2. Anamnesis	• Gangguan focal yang muncul mendadak, dapat berupa : • Kelompokan sesisi/kedua sisi, kelompokan satu extremitas, kelompokan otot-otot penggerak bola mata, kelompokan otot-otot untuk proses menelan, wicara dan sebagainya • Gangguan fungsi keseimbangan • Gangguan fungsi penghidu • Gangguan fungsi penglihatan • Gangguan fungsi pendengaran • Gangguan fungsi Somatik Sensoris • Gangguan fungsi autonom • Gangguan Neurobehavioral yang meliputi : ○ Gangguan atensi ○ Gangguan memori ○ Gangguan bicara verbal ○ Gangguan mengerti pembicaraan ○ Gangguan pengenalan ruang ○ Gangguan fungsi kognitif lain
3. Pemeriksaan Fisik	Status generalis : kesadaran (Glasgow Coma Scale), vital sign (TD, Nadi, RR, Temperatur) dan pemeriksaan umum lainnya Status neurologis : ditemukan adanya defisit neurologis pada salah satu atau lebih dari pemeriksaan berikut ini: pemeriksaan saraf-saraf kranialis, fungsi motorik, sensorik, luhur, vegetatif, gejala rangsang meningeal, gerakan abnormal (pemeriksaan <i>National Institutes of Health Stroke Scale</i>).
4. Kriteria Diagnosis	• Anamnesis yang cermat dan pemeriksaan fisik ditemukan adanya deficit neurologik focal • Kejadian mendadak, lebih dari 24 jam atau kurang dari 24 jam tapi penderita meninggal • Gambaran iskemia otak pada pemeriksaan imaging (CT scan tanpa kontras) • Adanya factor risiko vaskuler yang mendasari terjadinya stroke • Siriraj score < -1 ^[1]_{SEP}
5. Diagnosis Kerja	CVA Thrombosis

6. Diagnosis Banding	Lesi structural intracranial: SDH, tumor, AVM, stroke ICH minimal, stroke emboli Trauma kepala Infeksi CNS: arteritis pada ensefalitis, abses otak, subdural empiema, PML Migrain Epilepsi: parsial seizure, Todd's paresis Transient global amnesia Kelainan metabolik: hipoglikemia, hiperglikemia, encephalopathi hepatic, ensefalopati wernicke, ensefalopati hipertensi Kelainan labirin Kelainan psikologis: konversi, panik Multiple sclerosis Kelainan neuromuscular: mononeuropati, radikulopati, myasthenia gravis, "<i>motor neuron disease</i>"
7. Pemeriksaan Penunjang	• CT Scan Kepala/MRI Kepala tanpa kontras • GDA, GD 1/2 untuk memeriksa riwayat DM • Thoraks untuk memeriksa riwayat penyakit jantung • Laboratorium profil lipid untuk memeriksa riwayat dislipidemi, Ur/Cr, serum elektrolit • EKG
8. Terapi	a. Tatalaksana ruang gawat darurat: • Stabilisasi jalan nafas dan pernapasan • Evaluasi segera a) Menggali riwayat • Onset gejala • Riwayat penyakit sekarang: stroke, infark miokard, trauma, pembedahan, perdarahan • Penyakit penyerta: hipertensi dan diabetes melitus • Riwayat pengobatan: antikoagulan, insulin, antihipertensi b) Melakukan pemeriksaan fisik umum • Kepala leher • Tanda trauma • Pemeriksaan karotis (bruit) • Gagal jantung kongestif (distensi vena jugular) ○ Thoraks: - Iskemia jantung - Katup jantung - Ritme irregular ○ Abdomen: mencari komorbid ○ Ekstermitas: - Disfungsi hepatic (jaundice) - Koagulopati - Gangguan platelet (purpura, ptekie)

	a. Melakukan pemeriksaan fisik neurologis dan skala stroke NIHSS b. Melakukan tes diagnostic (pemeriksaan tambahan) c. Melakukan tes jantung b. Menegakkan diagnosis dengan segera: imejing otak dan pembuluh darah Imejing (CT scan kepala tanpa kontras) direkomendasikan sebelum memulai terapi spesifik stroke iskemik akut, namun terapi emergensi stroke tidak boleh terlambat hanya untuk mendapatkan hasil imejing. c. Tatalaksana umum dan penyulit akut • Memelihara jalan nafas, ventilator, dan pemberian oksigen tambahan ○ Pasien stroke akut yang mengalami penurunan kesadaran atau mengalami disfungsi bulbar sehingga jalan nafasnya mengalami kompresi harus mendapat dukungan ventilator ○ Pasien hipoksik harus mendapat oksigen tambahan ○ Pasien stroke iskemik akut nonhipoksik tidak membutuhkan terapi oksigen tambahan • Mengatasi febris ○ Pemberian obat antipiretika, kompres dingin, dan mengatasi sumber penyebabnya ○ Hipotermia direkomendasikan sebagai terapi stroke akut • Monitoring dan terapi jantung ○ Dilakukan untuk penapisan atrial fibrilasi dan aritmia jantung yang membutuhkan intervensi jantung emergensi ○ Dilakukan pada 24 jam pertama. Aritmia jantung harus segera diterapi. • Hipertensi arterial ○ Mengelola tekanan darah. Antihipertensi diberikan jika tekanan sistolik > 220 mmHg atau diastolic > 120 mmHg ○ Pemberian obat antihipertensi pada keadaan tekanan darah < 220/120 mmHg dilakukan jika ada rencana pemberian rtPA, atau stroke akut dengan hipertensi disertai ensefalopati hipertensif, diseksi aorta, gagal ginjal akut, edema paru akut, gagal jantung kiri, infark miokard akut. ○ Karena penurunan tekanan darah secara cepat dapat memperburuk kondisi otak, maka pemberian nifedipine sublingual dan antihipertensi lain yang mengakibatkan penurunan tekanan darah dengan cepat, harus dihindari • Hipotensi arterial Penyebab hipotensi arterial harus dicari. Hipovolemia harus dikoreksi dengan normal saline dan aritmia jantung yang dapat menyebabkan penurunan <i>cardiac output</i> harus dikoreksi • Memantau dan mengelola kadar glukosa darah
--	--



	○ Pada stroke iskemik akut, hipoglikemia maupun hiperglikemia dapat memperburuk kondisi otak ○ Hiperglikemia mengakibatkan semakin meluasnya sel otak karena asidosis laktat. Karena itu, kadar gula darah di atas 200 mg harus segera diturunkan dengan suntikan insulin. Kadar gula darah yang diinginkan adalah 80-140 mg/dL. Demikian pula, setiap tindakan yang dapat mengakibatkan hiperglikemia, seperti pemberian infuse dekstrose, harus dihindarkan. ○ Hiperglikemia persisten (>140 mg/dL) selama 24 jam pertama stroke berhubungan dengan keluaran buruk ○ Hipoglikemia pada pasien stroke iskemik akut harus diterapi. Kadar gula diharapkan dapat mencapai normoglikemia. Hindari peningkatan kadar gula yang berlebihan d. Melakukan penatalaksanaan khusus (terapi spesifik fase akut) Terapi spesifik pada stroke iskemik akut meliputi: a. Antiplatelet: • Obat antiplatelet oral tunggal: • Direkomendasikan aspirin oral (dengan dosis awal 325 mg) dalam 24 sampai 48 jam onset stroke b. Pemberian obat neuroprotektan, misalnya Citicoline yang diduga dapat melindungi neuron dari kematian sel akibat iskemia, dapat diberikan sejak dini. c. Antikoagulan: heparin dan LMWH Terapi antikoagulan intravena yang diberikan sangat dini berguna pada pasien dengan infark sekunder akibat thrombosis arteri besar atau kardioemboli (Clas III, Level of Evidence A) b. Melakukan terapi komplikasi neurologis akut. (a) Edema otak iskemik Pada stroke iskemik akut, edema otak sering terjadi pada hari ke 3-5 setelah serangan. Edema otak dapat mengakibatkan peningkatan tekanan intracranial, selanjutnya menimbulkan herniasi dan kompresi batang otak. Penatalaksanaan edema otak dengan peningkatan tekana intracranial adalah: i. Elevasi tempat tidur pada bagian kepala 30 derajat, untuk membantu memperbaiki aliran darah vena ii. Hiperventilasi (dengan ventilator) sampai PCO₂ 30-35 mmHg. Penurunan PCO₂ ini dapat mengakibatkan vasokonstriksi serebral sehingga menurunkan tekana intracranial sebesar 25-30%. Hiperventilasi ini hanya bisa dilakukan untuk sementara waktu saja, karena vasokonstriksi serebral yang ditimbulkan dapat memperberat iskemia. iii. Osmoterapi dengan menggunakan larutan mannitol 20%, diberikan dengan dosis awal 1-1,5 g/kg berat badan selama 20 menit, dilanjut dosis 0,25-0,5 g/kg berat badan setiap 4-6 jam. iv. Kortikosteroid (dosis biasa maupun dosis besar)
--	---

	tidak direkomendasikan untuk terapi edema otak dan peningkatan tekanan intracranial akibat stroke iskemik. (b) Transformasi perdarahan Sekitar 5% kasus stroke iskemik akut akan mengalami transformasi perdarahan simptomatik. Penggunaan obat antitrombotik, terutama trombolitik dan antikoagulan, dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya transformasi perdarahan pada infark otak. Dalam hal tersebut, penggunaan trombolitik dan antikoagulan harus segera dihentikan. (c) Kejang - Kejang pada umumnya terjadi sejak kurun waktu 24 jam setelah serangan, seringkali parsial dengan atau tanpa diikuti kejang umum. Kejang yang berlangsung terus menerus (kejang status) dapat berakibat fatal. Carbamazepine merupakan pilihan pertama obat kejang pada stroke iskemik akut, akan tetapi, jika kejang berlangsung serial atau status, pemberian injeksi phenitoin intravena lebih cepat mencapai kadar terapeutik dalam darah. - Kejang berulang setelah stroke harus diterapi karena berhubungan dengan kondisi neurologis akut - Terapi profilaksis antikonvulsan pada pasien dengan stroke tidak mengalami kejang tidak direkomendasikan f. Pemantauan terhadap kemungkinan terjadinya penyulit medik, misalnya penyulit pada: (a) Jantung (b) Paru (pneumonia) - Apabila ada dugaan pneumonia direkomendasikan untuk diterapi dengan antibiotik - Terapi profilaktik antibiotik tidak dibutuhkan (c) Saluran cerna: perdarahan Perlu juga diperhatikan nutrisi pasien: - Sebelum memulai minum atau makan, direkomendasikan untuk menanyakan bisa tidaknya pasien menelan - Pasien yang tidak dapat menelan makanan atau minuman hendaknya dipasang NGT untuk mempertahankan hidrasi dan nutrisi sambil menunggu usaha pengembalian fungsi menelan - Nutrisi suplemen tidak dibutuhkan (d) Saluran kemih: infeksi - Apabila ada dugaan infeksi saluran kemih direkomendasikan untuk diterapi dengan antibiotik - Terapi profilaktik antibiotik tidak dibutuhkan (e) Dekubitus (f) Trombosis vena dalam (g) Sepsis - Pasca/Post KRS: Antipaleletet: asesotal 80 mg/hr
--	---

9. Edukasi	Bertujuan melakukan pencegahan sekunder (serangan ulang stroke) dengan memberikan konseling kepada penderita dan keluarganya, diantaranya: c) Pengaturan diet dengan mengkonsumsi makanan rendah lemak jenuh dan kolesterol, tinggi serat, tinggi protein, mengandung antioksidan d) Pengendalian faktor-faktor resiko yang telah diketahui dengan obat-obat yang telah diberikan selama dirawat dan rutin kontrol berobat pasca dirawat e) Memodifikasi gaya hidup (olahraga, tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, penurunan berat badan pada obesitas) f) Melanjutkan fisioterapi dengan berobat jalan
10. Prognosis	Ad vitam Tergantung berat stroke dan komplikasi yang timbul
11. Tingkat Evidens	Class I
12. Tingkat Rekomendasi	Level A
13. Penelaah Kritis	dr. Ahmad Farid Wajdi, Sp.N dr. Akhmad Syahrir, Sp.N dr. Dewi Maharani, Sp.N dr. Fahimma, Sp.N., M. Biomed
14. Indikator Medis	• Semua faktor-faktor resiko pada penderita stroke telah diidentifikasi dan diatasi dengan pendekatan multidisiplin • Perbaikan klinis penderita stroke • NIHSS • Konseling terhadap pasien stroke dan keluarga ttg perawatan di rumah (home care) dan kontrol rutin pasca perawatan utk pencegahan sekunder stroke
15. Kriteria Pulang	- Keadaan umum membaik - Komplikasi stroke trombotik tertangani
16. Kepustakaan	- Standar Pelayanan Medis Neurologi 2006 - Standar Pelayanan Operasional 2006 - AHA/ASA Guideline Stroke 2011

2. Dengue Fever

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA 2026
DEMAM DENGUE	
1. Pengertian (Definisi)	Demam dengue adalah suatu penyakit demam akut yang disebabkan oleh virus genus Flavivirus, family Flaviviridae yang mempunyai 4 serotipe yaitu DEN 1, DEN 2, DEN 3 dan DEN 4 melalui perantara nyamuk aedes aegypti atau Aedes albopictus. Den-3 merupakan serotype dominan dan berhubungan dengan kasus yang berat.
2. Anamnesis	a. Demam hari ke 3-5 dengan <7 hari b. Nyeri kepala, nyeri otot, nyeri perut c. Lesu, anoreksia, mual, muntah d. Kadang diare e. Perdarahan paling sering yaitu perdarahan kulit dan mimisan
3. Pemeriksaan Fisik	a. Demam (mendadak tinggi). b. Bisa didapatkan nyeri abdomen
4. Kriteria Diagnosis	Minimal 2 atau lebih dari gejala berikut a. Demam mendadak tinggi 2-7 hari b. Cefalgia, mialgia, nyeri perut c. Trombositopenia (150.000/μL atau kurang)
5. Diagnosis Kerja	Dengue Fever (ICD 10: A90)
6. Diagnosis Banding	a. Typhoid fever b. Chikungunya c. Demam berdarah dengue grade I dan II
7. Pemeriksaan Penunjang	a. Darah lengkap b. Trombosit serial
8. Terapi	a. Kebutuhan cairan harus dipenuhi (sesuai usia dan BB berikut insensible water loss) *sesuai algoritma DHF b. Inj. Cefotaxim/ Ceftriaxon bila ada penyakit penyerta c. Peroral: parasetamol 15-20 mg/kgBB/kali, 4- 6 x/hari, antivirus
9. Edukasi	a. Pemberian Informasi Diagnosis b. Pemberian Informasi Tindakan c. Gizi dan Pola Hidup
10. Prognosis	Dubia ad bonam
11. Kriteria Pulang	Tidak demam, trombosit >100.000/ μ L dan naik 2x.
12. Tingkat Evidens	IV
13. Tingkat Rekomendasi	C
14. Penelaah Kritis	dr. Ardhi Bustami, Sp.PD dr. Ardityo Rahmat Ardhany, Sp.PD, K-GH dr. Heriyatmo, Sp.PD dr. Zoraida Dwi Wahyuni, Sp.PD
15. Indikator Medis	Vital sign normal Tidak ditemukan gangguan intestinal maupun hemodinamik
16. Kepustakaan	a. Pedoman pelayanan Medis IDAI jilid 1. 2010

3. DM Ulkus dengan Tindakan Debridement

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TAHUN 2026
DM ULKUS	
1. Pengertian (Definisi)	Kaki diabetes, <i>ulkus/gangren</i> adalah luka terbuka dengan/tanpa nyeri pada kaki yang merupakan komplikasi diabetes karena penurunan sensasi pada kaki yang membuatnya rentan terhadap injuri. Gula darah yang tidak terkendali akan menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah yang akan menyebabkan menurunnya aliran darah ke kaki sehingga penyembuhan luka menjadi terhambat Fokus penanganan kaki diabetes adalah untuk menghindari amputasi.
2. Anamnesis	• Lamanya mengidap diabetes • Kendali glukosa darah sebelumnya • Adanya komplikasi/komorbiditas lainnya seperti gagal ginjal, resiko kardiovaskular (hipertensi, hiperlipidemia, merokok, angina, infark miokard, transient ischemic attack, stroke, peripheral vascular disease) • Alas kaki yang dipergunakan • Paparan/paparan kaki dengan zat-zat kimia • Ada/tidaknya callus, ataupun deformitas pada kaki • Riwayat infeksi kaki atau pembedahan pada kaki sebelumnya • Keluhan-keluhan neuropati • Keluhan-keluhan klaudikasio atau nyeri saat beristirahat • Riwayat luka saat ini • Riwayat penyembuhan luka sebelumnya • Pemeriksaan dan terapi yang sudah dilakukan serta hasilnya • Implikasi fungsional dan sosial pada pasien • Riwayat alkohol, merokok dan depresi
3. Pemeriksaan Fisik	• Tekanan darah, nadi, pernafasan

	• Pemeriksaan penapisan neurologi : pemeriksaan sensori untuk neuropati dengan monofilament Semmes-Weinstein, pinprick sensation, persepsi getar dengan garpu tala 128 Hz, ankle deep tendon refleksi, vibration perception threshold testing. • Pemeriksaan evaluasi vaskular : palpasi/perabaan nadi femoral, poplitea dan pedal, ankle brachial index (ABI) dan/atau toe brachial index (TBI) • Pemeriksaan ulkus yang meliputi pemeriksaan perubahan struktur kulit, termasuk kalus, deformitas muskuloskeletal dan <i>muscle wasting</i>. • Dokumentasi karakteristik dari ulkus termasuk lokasi, ukuran, dan bentuk (penghitungan panjang, lebar dan dalamnya) • Dokumentasi kondisi dari tepi luka, dasar luka dan eksudat yang ada serta melihat adanya nekrosis dan nyeri. • Melihat komplikasi yang mungkin sudah ada seperti selulitis, gangren, osteomyelitis ataupun deformitas dari charcot														
4. Kriteria Diagnosis	Klasifikasi Wagner untuk Kaki diabetes <table border="1"> <thead> <tr> <th>Derajat luka</th><th>Lesi</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td><td>Tidak ada luka terbuka, bisa dengan deformitas/celulitis</td></tr> <tr> <td>1</td><td>Ulkus yang superficial</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Ulkus yang mengenai tendon atau kapsul sendi</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Ulkus dalam dengan abses, osteomyelitis atau sepsis</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Gangren lokal – tumit atau ka</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Gangren seluruh kaki</td></tr> </tbody> </table>	Derajat luka	Lesi	0	Tidak ada luka terbuka, bisa dengan deformitas/celulitis	1	Ulkus yang superficial	2	Ulkus yang mengenai tendon atau kapsul sendi	3	Ulkus dalam dengan abses, osteomyelitis atau sepsis	4	Gangren lokal – tumit atau ka	5	Gangren seluruh kaki
Derajat luka	Lesi														
0	Tidak ada luka terbuka, bisa dengan deformitas/celulitis														
1	Ulkus yang superficial														
2	Ulkus yang mengenai tendon atau kapsul sendi														
3	Ulkus dalam dengan abses, osteomyelitis atau sepsis														
4	Gangren lokal – tumit atau ka														
5	Gangren seluruh kaki														
5. Diagnosis Kerja	Diabetic Foot (ICD 10: ICD 10)														
6. Diagnosis Banding	Superficial thromboflebitis Diabetic dermopathy Chronic venostatic change Gas gangrene														
7. Pemeriksaan Penunjang	• Darah lengkap • Gula Darah • Elektrolit • Kultur darah • Serum Keton dan Laktat • Ureum dan kreatinin, AST/ALT, albumin • Foto pedis • LED/CRP • Segmental pressure pulse volume • Skin perfusion pressure														

	• Transcutaneous oxygen tension • Angiography • Magnetic resonance angiography
8. Terapi	• Debridement • Pengendalian infeksi dan inflamasi • Pengendalian kelembaban • Eksisi tepi luka dan kalus jika dibutuhkan • Penatalaksanaan <i>off-loading</i> • Rehabilitasi
9. Edukasi	1. Pengendalian gula darah yang baik 2. Penggunaan alas kaki yang melindungi 3. Evaluasi terhadap lingkungan sekitar 4. Mengendalikan faktor resiko lainnya seperti merokok, hipertensi dan abnormalitas lemak) 5. Cara membuang kalus
6. Prognosis	Ad vitam : bonam Ad sanationam : bonam Ad fungtionam : bonam
7. Tingkat Evidens	IV
8. Tingkat Rekomendasi	A/B/C
9. Penelaah Kritis	dr. Andi Abdillah, Sp.B dr. Antonius Setiadi, Sp. B dr. Iwan Donosepoetro, SP.B., FINACS dr. Rossy Zaki Abdillah, Sp.B dr. Heriyatmo, Sp.PD dr. Ardhi Bustami, Sp. PD dr. Adhya Aji Pratama, Sp.PD dr. Zoraida Dwi Wahyuni, Sp.PD dr. Ira Setya Waty, Sp.JP dr. Miryanti Cahyaningtias, Sp.JP dr. Yoga Waranugraha, Sp.JP (K)
10. Indikator Medis	1. Teratasinya infeksi 2. Luka membaik 3. Gula darah terkendali
11. Kepustakaan	1. Kirsber RS, Herman HW, Funnel MM. The standard of care for evaluation and treatment of diabetic foot ulcer. University of Michigan, 2012



4. Kejang Demam

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TAHUN 2026
KEJANG DEMAM	
1. Pengertian (Definisi)	Kejang demam adalah bangkitan kejang yang terjadi karena kenaikan suhu tubuh (suhu rektal diatas 38⁰ C) yang disebabkan oleh suatu proses ekstrakranium. Suatu kejadian pada bayi dan anak, biasanya terjadi antara umur 3 bulan dan 5 tahun, berhubungan dengan demam tetapi tidak terbukti adanya infeksi intrakranial atau penyebab tertentu.
2. Anamnesis	1. Kejang: kapan terjadi, berapa kali/ 24 jam, lama tiap kejang, bentuk kejang, kesadaran saat kejang dan setelah kejang terjadi 2. Demam: kapan terjadi, berapa lama jarak antara demam dan kejang, berapa suhunya, berapa suhu saat kejang 3. Faktor predisposisi: batuk, pilek, cairan dari telinga, gigi/mulut yang sakit, mual, muntah, mencret, BAK 4. Riwayat terapi 5. Faktor kejang demam atau epilepsi pada anggota keluarga lain
3. Pemeriksaan Fisik	1. Pemeriksaan fisik, termasuk <i>vital sign</i> 2. Pemeriksaan neurologis: kesadaran, kepala: bentuk, ukuran, tanda rangsang meningeal, nervus kranialis, sensorik, motorik, refleks fisiologis, refleks patologis, klonus
4. Kriteria Diagnosis	1. Kejang demam sederhana: Kejang berlangsung singkat, < 15 menit, sifat kejang umum tonik dan atau klonik, umumnya berhenti sendiri, tanpa gerakan fokal atau berulang dalam 24 jam 2. Kejang demam kompleks: Kejang lama > 15 menit, kejang fokal atau parsial satu sisi, atau kejang umum didahului kejang parsial, berulang atau lebih dari 1 kali dalam 24 jam.
5. Diagnosis Kerja	Kejang demam (ICD 10: R56.0)
6. Diagnosis Banding	1. Meningitis 2. Ensefalitis 3. Epilepsi
7. Pemeriksaan Penunjang	1. Pemeriksaan laboratorium : Pemeriksaan rutin tidak dianjurkan, kecuali untuk mengevaluasi sumber infeksi atau mencari penyebab (darah tepi, elektrolit dan gula darah). 2. Pemeriksaan radiologi : CT Scan kepala, USG kepala, atau MRI tidak rutin dan hanya dikerjakan jika ada indikasi 3. Pemeriksaan cairan serebrospinal (CSS) :



	Tindakan pungsi lumbal untuk pemeriksaan CSS dilakukan untuk menegaskan atau menyingkirkan kemungkinan meningitis. Pada bayi kecil, klinis meningitis tidak jelas, maka tindakan pungsi lumbal dikerjakan dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Bayi < 12 bulan : diharuskan 2. Bayi antara 12-18 bulan : dianjurkan 3. Bayi > 18 bulan : tidak rutin, kecuali bila ada tanda-tanda meningitis. 4. Pemeriksaan elektroensefalografi (EEG) : Tidak direkomendasikan, kecuali pada kejang demam yang tidak khas (misalnya kejang demam komplikata pada anak usia > 6 tahun atau kejang demam fokal).
8. Terapi	1. Penanganan Pada Saat Kejang • Menghentikan kejang: Diazepam dosis awal 0,3-0,5 mg/KgBB/dosis IV (perlahan-lahan) atau 0,4-0,6mg/KgBB/dosis REKTAL SUPPOSITORIA. Bila kejang masih belum teratasi dapat diulang dengan dosis yang sama 20 menit kemudian. • Turunkan demam : ○ Antipiretika : Paracetamol 10 mg/KgBB/dosis PO atau Ibuprofen 5-10 mg/KgBB/dosis PO, keduanya diberikan 3-4 kali perhari ○ Kompres : suhu > 39⁰ C : air hangat; suhu > 38⁰ C : air biasa ○ Pengobatan penyebab : antibiotika diberikan sesuai indikasi dengan penyakit dasarnya. ○ Penanganan suportif lainnya meliputi : ▪ Bebaskan jalan nafas ▪ Pemberian oksigen ▪ Menjaga keseimbangan air dan elektrolit ▪ Pertahankan keseimbangan tekanan darah 2. Pencegahan Kejang • Pencegahan berkala (intermiten) untuk kejang demam sederhana dengan Diazepam 0,3 mg/KgBB/dosis PO dan antipiretika pada saat anak menderita penyakit yang disertai demam. • Pencegahan kontinu untuk kejang demam komplikata dengan Asam Valproat 15-40 mg/KgBB/hari PO dibagi dalam 2-3 dosis.
9. Edukasi	1. Kompres badan ketika demam: suhu > 39⁰ C : air hangat; suhu > 38⁰ C : air biasa 2. Pemberian antipiretik 3. Edukasi bisa terulang kembali kejang demam atau menjadi komplikasi epilepsi, apabila terdapat riwayat kejang demam dalam keluarga, usia < 12 bulan, temperatur yang rendah saat kejang, cepatnya kejang setelah demam. 4. Menyediakan diazepam rektal suppositoria 5 mg untuk berat badan < 10 kg dan 10 mg untuk berat badan > 10 kg. Bila kejang masih belum teratasi dapat diulang dengan dosis yang sama 20 menit kemudian. 5. Edukasi tentang indikasi rawat inap:



	• Kejang demam komplikata • Hiperpireksia • Usia dibawah 6 bulan • Kejang demam pertama • Terdapat kelainan neurologis	
10. Prognosis	Ad vitam Ad sanationam Ad fungsionam	: dubia ad bonam / malam : dubia ad bonam / malam : dubia ad bonam / malam
11. Kriteria Pulang	Tidak demam, kondisi umum membaik	
12. Tingkat Evidens	I / II / III / IV	
13. Tingkat Rekomendasi	A / B / C	
14. Penelaah Kritis	dr. Dicky Faturrachman, Sp.A, BIOMED dr. Fiona Paramitha, Sp.A dr. Ratih Kusumawardani, Sp. A., M. Biomed	
15. Indikator Medis		
16. Kepustakaan	1.Baumann RJ. Febrile Seizures. E Med J, March 12 2002, vol. 2, No. 3 : 1-10 2.Baumann RJ. Technical Report: Treatment of The Child with Simple Febrile Seizures. http://www.pediatric.org/cgi/content/full/103/e86 . 3.Lewis H. Viruses in Febrile Convulsion. Arch Dis Child, 2001; 82 : 428. 4.Konsensus penatalaksanaan kejang demam UKK Neurologi IDAI 2006	

5. Pneumonia

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TAHUN 2026
PNEUMONIA Rawat Inap Ruang Biasa	
1. Pengertian (Definisi)	Infeksi pada jaringan paru yang disebabkan oleh mikroorganisme.
2. Anamnesis	a. Batuk < 14 hari b. Sesak napas c. Demam tinggi
3. Pemeriksaan Fisik	a. Tampak sakit sedang sampai berat b. Tampak sesak dengan frekuensi napas > 20x/m c. Suhu Badan $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ d. Inspeksi: dada yang sakit tertinggal, Palpasi : stem fremitus meningkat. Auskultasi: suara napas bronkovesikuler sampai bronkial dapat disertai ronki
4. Kriteria Diagnosis	- Anamnesa - Pemeriksaan fisik - Foto thoraks
5. Diagnosis Kerja	Pneumonia (ICD 10: J 18.9)
6. Diagnosis Banding	a. Tuberkulosis paru b. Tumor paru c. Emboli paru
7. Pemeriksaan Penunjang	Foto Thoraks
8. Terapi	1. Suportif : Oksigen, IVFD 2. Antibiotik pilihan: a. Sefalosporin generasi III (Ceftriaxone 2x1 gr, Cefotaxim 3x1gr, b. Fluoroquinolon repirasi (Levofloxacin 1 x 500mg, Moxifloxacin 1x400mg) c. Makrolide baru (azythromycin 1x500mg, roxythromycin 2x150mg) 3. Simptomatis : Ambroxol 3x30 mg, DMP 3x15mg, Parasetamol 3x500 mg
9. Edukasi	a. Mengenal faktor resiko infeksi paru. b. Kontrol rutin ke poli paru.
10. Prognosis	Dubia ad bonam
11. Kriteria Pulang	Tidak didapatkan demam dan sesak, pada pemeriksaan paru tidak didapatkan rhonki maupun wheezing.
12. Tingkat Evidens	I
13. Tingkat Rekomendasi	C (consensus)
14. Penelaah Kritis	dr. Andy, Sp.P dr. Catur Elvi, Sp.P dr. Yunita Eka Wati, Sp.P
15. Indikator Medis	Keluhan dan gejala membaik



16. Kepustakaan	- Mandell LA, Wunderink RG, Anzueto A, Bartlett JG, Campbell GD, Dean NC. Infectious Diseases Society of America/American Thoracic Society Consensus Guidelines on the Management of Community-Acquired Pneumonia in Adults. <i>Clinical Infectious Diseases</i>. 2007; 44: S27–72 - PDPI, 2003. Pneumonia Komuniti: <i>Pedoman Diagnosis dan Penatalaksanaan di Indonesia</i>, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Jakarta. - Niederman MS, 2008. Principles of antibiotic use and the selection of empiric therapy for pneumonia In: <i>Fishman's Pulmonary Diseases and Disorders</i>. Chapter 115. Fourth Edition. McGraw Hill, New York, pp. 2051-2064 - American Thoracic Society. Guidelines for management of adults with community-acquired pneumonia. Diagnosis, assessment of severity, antimicrobial therapy, and prevention. <i>Am J Respir Crit. Care Med</i>. 2001; 163: 1730-5
-----------------	---